

FORMATION PLUS

UNITÉ PÉDAGOGIQUE DE SOINS INFIRMIERS

TECHNIQUES DE SOINS INFIRMIERS

FORMATION PLUS

SOMMAIRE

- 1. Préparation d'un patient pour une ponction lombaire
- 2. Soins pré, per et post opératoires en chirurgie digestive
- 3. Rôle de l'infirmier devant une occlusion intestinale
- 4. Rôle de l'infirmier devant une péritonite aiguë
- 5. Rôle de l'infirmier dans l'étranglement herniaire
- 6. Soins infirmiers dans les appendicites aiguës
- 7. Soins infirmiers dans les plaies et contusions abdominales
- 8. Rôle de l'infirmier au cours du lavage d'estomac
- 9. Soins infirmiers dans l'ulcère gastro-duodénal
- 10. Rôle de l'infirmier devant les hémorragies digestives
- 11. Soins infirmiers dans les hépatites virales
- 12. Rôle de l'infirmier au cours de la ponction d'ascite
- 13. Rôle de l'infirmier au cours du tubage gastrique
- 14. Rôle de l'infirmier au cours de l'aspiration digestive
- 15. Rôle de l'infirmier dans la fonction biopsique du foie
- 16. Soins de colostomie ou anus artificiel
- 17. Soins infirmiers en cas de gastrectomie
- 18. Soins infirmiers au patient présentant un traumatisme du rachis
- 19. Soins infirmiers au patient présentant un traumatisme du thorax
- 20. Soins infirmiers au patient présentant un traumatisme du bassin
- 21. Soins infirmiers au patient présentant un traumatisme du crâne
- 22. Surveillance d'un malade sous appareil plâtré
- 23. Prise en charge d'une personne en traction suspension et extension continue
- 24. Soins pré et post opératoire dans l'ostéosynthèse
- 25. Soins infirmiers à un malade présentant une dyspnée
- 26. Rôle de l'infirmier au cours du drainage de posture (DDP)
- 27. Soins infirmiers dans les aspirations des sécrétions bronchiques
- 28. Rôle de l'infirmier au cours de l'instillation bronchique
- 29. Rôle de l'infirmier dans le lavage de la plèvre
- 30. Soins infirmiers au cours du drainage pleural
- 31. Soins infirmiers dans la ponction de la plèvre
- 32. Rôle de l'infirmier devant une crise d'asthme et l'état de mal asthmatique
- 33. Soins infirmiers devant une hémoptysie
- 34. Rôle de l'infirmier au cours de l'insuffisance respiratoire aiguë
- 35. Rôle de l'infirmier dans l'hypertension artérielle
- 36. Prise en charge des urgences hypertensives
- 37. Soins infirmiers dans l'œdème aigu du poumon (OAP)
- 38. Soins infirmiers dans l'embolie pulmonaire
- 39. Rôle de l'infirmier dans l'angine de poitrine ou Angor
- 40. Rôle de l'infirmier dans l'infarctus du myocarde
- 41. Soins infirmiers à un malade atteint d'insuffisance cardiaque
- 42. Rôle de l'infirmier dans la phlébite
- 43. Soins infirmiers en pré et post opératoire en chirurgie cardio-vasculaire
- 44. CAT devant un malade présentant un AVC
- 45. Le prélèvement sanguin
- 46. Groupe sanguin
- 47. Transfusion sanguine
- 48. Rôle de l'infirmier dans les anémies
- 49. Soins infirmiers dans l'état de choc
- 50. CAT devant une syncope
- 51. Sondage vésical
- 52. Lavage de vessie
- 53. Rôle de l'infirmier devant une hématurie
- 54. Rôle de l'infirmier devant une insuffisance rénale aiguë
- 55. Rôle de l'infirmier devant l'insuffisance rénale chronique
- 56. Rôle de l'infirmier devant la colique néphrétique
- 57. Rôle de l'infirmier devant le syndrome néphrotique
- 58. Rôle de l'infirmier devant la pyélonéphrite aiguë
- 59. Conduite à tenir dans la rétention aiguë d'urine
- 60. Soins infirmiers dans l'adénomectomie de la prostate
- 61. Soins infirmiers dans le rhumatisme articulaire aigu (RAA)
- 62. Soins infirmiers à un patient atteint de la sciatique
- 63. Rangement d'une armoire à pharmacie
- 64. Surveillance d'un patient sous diurétiques

- 65. Surveillance d'un malade sous anticoagulants
- 66. Surveillance d'un patient sous insuline
- 67. Rôle de l'infirmier dans la corticothérapie par voie générale
- 68. Surveillance d'un malade sous corticoïdes et AINS
- 69. Surveillance d'un patient sous antibiotiques
- 70. Incidents et accidents dus aux sulfamides et antibiotiques

CHAPITRE I — SOINS INFIRMIERS GÉNÉRAUX

01 PRÉPARATION D'UN PATIENT POUR UNE PONCTION LOMBAIRE

DÉFINITION ET INDICATIONS

La ponction lombaire consiste à prélever du liquide céphalorachidien (LCR) au niveau du cul-de-sac méningé, au moyen d'une aiguille introduite entre deux arcs vertébraux lombaires. But : étude biochimique (protéinorachie, glycorachie) et bactériologique.

- **Indications** : anesthésie (rachianesthésie) ; diagnostic (suspicion de méningite, syndrome neurologique évoquant une hémorragie méningée, sclérose en plaques, tumeur cérébrale) ; thérapeutique (soustraction de liquide ou injection médicamenteuse).
- **Contre-indications** : hypertension intracrânienne, traitement anticoagulant en cours, troubles majeurs de l'hémostase.
- **Lieu de ponction** : chez l'adulte, entre L3 et L4 ; chez l'enfant, en dessous de L4 (L4-L5) ou espace sacro-lombaire.

RÔLE DE L'INFIRMIER

- **Avant** : préparation psychologique, patient à jeun de préférence, pose EMLA 1h avant, réunir le matériel d'asepsie et de ponction (2 aiguilles à PL, champ stérile, 3 tubes secs).
- **Pendant** : installer en position correcte (décubitus latéral ou assis dos rond), servir le médecin, recueillir 10-15 gouttes/tube (minimum 3), glycémie capillaire.
- **Après** : pansement sec, décubitus ventral sans oreiller 1-3h puis décubitus strict (prévenir céphalées), surveiller signes généraux et pouls, réhydrater mais attendre ~3h avant réalimentation.

INCIDENTS

- Ponction blanche (mauvaise position ou malade difficile)
- Obstacle osseux, écoulement très lent
- Issue de sang par l'aiguille, douleur vive (piqûre d'un nerf)
- Céphalée tardive avec rachialgie

À RETENIR

- La position correcte du malade est la condition absolue d'une bonne ponction : elle doit imprimer à la colonne lombaire un maximum de flexion.
- Après la ponction, le décubitus ventral sans oreiller puis le décubitus strict préviennent les céphalées et vomissements.

CHAPITRE II — SOINS INFIRMIERS DANS LA FONCTION DIGESTIVE

02 SOINS PRÉ, PER ET POST OPÉRATOIRES EN CHIRURGIE DIGESTIVE

DÉFINITIONS

- **Soins pré-opératoires** : actes avant l'intervention — expliquer le déroulement, éliminer la flore bactérienne transitoire par l'hygiène, obtenir le consentement.
- **Soins per-opératoires** : actes pendant l'opération au bloc — apprêter la salle de réveil et la chambre pour le retour du patient.
- **Soins post-opératoires** : actes après l'intervention — essentiellement la surveillance de l'opéré.

PRÉPARATION DU PATIENT

- **Psychologique** : écouter craintes/appréhensions, climat de confiance, DEMANDER LE CONSENTEMENT.
- **Physique (veille)** : toilette+hygiène bucco-dentaire, rasage large du site opératoire, jeûne 6-8h avant, dossier pré-opératoire complet, prémédication 48h avant, ôter prothèses dentaires, sonde vésicale à demeure.

SURVEILLANCE POST-OPÉRATOIRE

Période	Éléments de surveillance
24 premières heures	Signes hémorragiques (pouls, TA), coloration, respiration (cyanose), hyperthermie, diurèse horaire, plaie et drains, calmants si douleur

Période	Éléments de surveillance
Après 48 heures	Lever précoce (prévention phlébite/embole), reprise du transit, ablation SNG sur ordre médical, réalimentation progressive, pansement/fils sur avis médical
À RETENIR - Le retour du malade du bloc opératoire ne doit jamais être improvisé : la chambre doit être prête à l'avance. - Le malade opéré doit être calme, rose, chaud et sec, et ne doit pas présenter de signes de douleur.	

03 RÔLE DE L'INFIRMIER DEVANT UNE OCCLUSION INTESTINALE

PHYSIOPATHOLOGIE

6 à 8 litres de liquide digestif transitent normalement chaque jour et sont réabsorbés avant le côlon. En occlusion, ce liquide s'accumule en amont, la distension abdominale diminue l'absorption et augmente les sécrétions, la pression intraluminaire augmente la perméabilité capillaire et le passage d'électrolytes vers la cavité péritonéale — d'où une hypovolémie possible. En cas de volvulus/strangulation, l'intestin privé de sang peut nécroser si la chirurgie n'est pas immédiate.

RÔLE DE L'INFIRMIER

- Établissement de 1er contact** : climat de confiance/calme, rapidité sans affolement, bonne voie veineuse, SNG si matériel disponible, feuille d'évacuation (heure début douleurs, dernier gaz/selles), RÉFÉRER.
- Établissement de référence** : interrogatoire complet, surveillance TOUTES LES HEURES jusqu'à la chirurgie, bilan sanguin, réanimation hydro-électrolytique, aspiration gastrique continue, sonde urinaire, bilan urgence (radio pulmonaire, ASP, ECG), prémédication.
- Post-opératoire** : surveillance constantes/biologie, antibiotiques prescrits, interdiction alimentation avant reprise du transit, pansements aseptique rigoureuse.

À RETENIR

- La surveillance doit être renouvelée toutes les heures jusqu'à l'intervention chirurgicale.
- Le volvulus/strangulation impose une chirurgie immédiate pour éviter la nécrose intestinale.

04 RÔLE DE L'INFIRMIER DEVANT UNE PÉRITONITE AIGÜE

SOINS PRÉ-OPÉRATOIRES (DÈS L'ARRIVÉE)

- Climat de confiance et de calme, formalités administratives
- Interrogatoire rapide, constantes, courbes de surveillance
- Voie veineuse + bilan (hémogramme, ionogramme, amylasémie, hémostase, groupage)
- Réanimation hydro-électrolytique, aspiration gastrique continue (SNG)
- Sonde urinaire (diurèse), expliquer l'urgence chirurgicale, préparer le lit

SOINS POST-OPÉRATOIRES

- Surveillance constante et attentive, administrer/surveiller la thérapeutique
- Vérifier aspiration/drains et pansements (avis médical), pansement plaie J2-J3
- Surveiller la reprise du transit, éducation alimentaire (début liquidien)
- Prévention des escarres par changement de position

À RETENIR

- Si la péritonite est due à une perforation d'ulcère gastro-duodénal, un traitement étiologique spécifique s'ajoute : sonde gastrique, aspiration, jeûne strict.
- La péritonite aiguë est une urgence chirurgicale : l'infirmier doit expliquer clairement cette nécessité au patient.

05 RÔLE DE L'INFIRMIER DANS L'ÉTRANGLEMENT HERNIAIRE

SOINS PRÉ-OPÉRATOIRES

- **Recueil de données** : antécédents (éthylisme, tabagisme, pathologies associées).
- **Préparation locale** : douche pré-opératoire à la bétadine scrub, dépilation abdominale.
- **Jour J** : constantes de référence, douche bétadine, bas de contention, prémédication.

SURVEILLANCE POST-OPÉRATOIRE

- **Immédiate (6h puis /2h)** : conscience, risque hémorragique (pouls, TA, coloration, pansement), risque respiratoire, douleur, reprise diurèse (risque rétention aiguë).
- **Ultérieure** : lever précoce J1 (limiter risque thrombo-embolique), réalimentation rapide (boisson/bouillon le soir même), mettre un SLIP au patient (éviter hématome scrotal douloureux).

À RETENIR

- Le lever précoce dès J1 (voire J0 selon l'état du patient) limite le risque thrombo-embolique.
- Un slip de maintien évite qu'un hématome ne descende dans les bourses et ne crée une douleur significative.

06 SOINS INFIRMIERS DANS LES APPENDICITES AIGÜES

SOINS ET SURVEILLANCE PRÉ-OPÉRATOIRES

- Bilan pré-opératoire, bon débit urinaire, perfusions IV pour compenser les pertes
- Surveiller fièvre/infection (température), lutter par les médicaments prescrits
- Sonde naso-gastrique si iléus paralytique, préparer le champ opératoire, prémédication
- Demander au malade d'uriner avant de l'envoyer au bloc

SOINS POST-OPÉRATOIRES

- Position demi-assise ou Fowler dès le réveil (avec ou sans drainage)
- Surveillance horaire 6 premières heures puis toutes les 2 heures
- Réalimentation progressive selon le chirurgien, surveiller reprise du transit
- Éviter la compression du drain, traitement et hygiène prescrits

À RETENIR

- Les soins post-opératoires suivent le même schéma que pour toute chirurgie digestive : surveillance horaire rapprochée puis espacée.

07 SOINS INFIRMIERS DANS LES PLAIES ET CONTUSIONS ABDOMINALES

CONDUITE À TENIR EN URGENCE

- Accueillir, installer, rassurer le blessé ; prévenir le chirurgien en urgence
- S'assurer que le patient reste à jeun strict, déshabiller sans trop mobiliser
- Immobiliser les fractures éventuelles
- **Mettre en place** : voie veineuse périphérique gros calibre + sérum glucosé, dispositif de recueil des urines
- Préparer le champ opératoire de façon large (du pubis au thorax), toilette complète
- **Bilan préopératoire** : groupe sanguin+rhésus, NFS, plaquettes, ionogramme, urémie, créatininémie, glycémie, crase sanguine (TP, TCA)
- Radios + ECG, drap propre, dossier complet, transport au bloc

SURVEILLANCE POST-INTERVENTIONNELLE

- État de conscience
- Douleur
- Fréquence cardiaque (pouls)
- Pression artérielle
- Diurèse
- Coloration des téguments
- Soif et présence de sueurs

À RETENIR

- Le champ opératoire doit être préparé de façon très large (du pubis au thorax) devant toute plaie abdominale, car l'étendue des lésions internes est imprévisible.

08 RÔLE DE L'INFIRMIER AU COURS DU LAVAGE D'ESTOMAC

DÉFINITION ET INDICATIONS

Le lavage d'estomac est une technique d'élimination de certaines toxines contenues dans l'estomac.

- **Indications** : avant intervention sur l'estomac, vomissement incoercible, ingestion trop grande de boissons alcoolisées, intoxication médicamenteuse (dès que possible, avec l'antidote si disponible).
- **Contre-indications** : coma profond, sang dans les vomissures, ulcère de l'estomac, muqueuse gastrique ulcérée par produit corrosif (risque de perforation).

MATÉRIEL ET INCIDENTS

- **Matériel** : tube de Faucher + entonnoir, seau, alèses, haricot, verre eau de rinçage, cuvette eau de lavage.
- **Incidents** : impossibilité d'introduire le tube (sujets nerveux), nausées.
- **Accident** : fausse route.

À RETENIR

- Le lavage d'estomac comporte des risques : il faut nécessairement connaître les contre-indications avant de le pratiquer.

09 SOINS INFIRMIERS DANS L'ULCÈRE GASTRO-DUODÉNAL

RÔLE INFIRMIER

Le but du traitement est de soulager le malade, permettre la cicatrisation et prévenir les complications — le rôle infirmier est axé sur la surveillance du malade et de ses complications.

- Expliquer les modalités du traitement et la nécessité de le poursuivre, repos physique/moral
- Régime alimentaire large SANS épices ni alcool ; diminuer/supprimer le tabac (surtout à jeun le matin)
- Pansements gastriques 1/4h avant chaque repas, surveiller le transit
- **Contre-indications médicamenteuses** : anticoagulants, AIS, AINS (risque de rechute et d'hémorragie).
- Évaluer la douleur épigastrique avant chaque repas, peser 1×/semaine
- Surveiller l'aspect des selles (noires = présence de sang)

À RETENIR

- Des vomissements survenant plusieurs heures après le repas doivent faire penser à une sténose du pylore.
- Une douleur épigastrique brutale et violente avec syncope doit faire penser à une PERFORATION : appeler le médecin en urgence.

10 RÔLE DE L'INFIRMIER DEVANT LES HÉMORRAGIES DIGESTIVES

RÔLE PROPRE ET RÔLE DÉLÉGUÉ

- **Rôle propre** : accueillir/installer, distinguer hémoptysie/hématémèse, évaluer l'importance du saignement, tête basse sur le côté (éviter l'inhalation), prévenir le médecin en urgence.
- **Rôle délégué** : 2 voies veineuses gros calibre + macromolécule, oxygène, surveillance (TA, pouls, coloration), si abondante → 2 culots iso-groupe/iso-Rh + plasma frais congelé.

GESTES SPÉCIFIQUES

- **Sonde de BLAKEMORE** : tamponnement local des varices œsophagiennes en attendant la fibroscopie.
- **Sonde gastrique** : vérifier si le saignement est actif, vidanger, laver à l'eau froide jusqu'à obtention d'un liquide clair.

Type de surveillance	Éléments
Clinique	Sang rejeté, constantes (TA, pouls, FR), diurèse, coloration, conscience
Biologique	NFS, plaquettes, hématocrite, hémostase, ionogramme, bilan hépatique
Transfusion	Angoisse, frissons, cyanose, dyspnée, douleurs lombaires, rythme de transfusion

À RETENIR

- La distinction entre hémoptysie et hématémèse est le premier réflexe

Type de surveillance	Éléments
diagnostique devant tout saignement extériorisé.	

11 SOINS INFIRMIERS DANS LES HÉPATITES VIRALES

ACCUEIL, SOINS ET SURVEILLANCE

- **Accueil** : isoler en chambre individuelle, matériel d'usage individuel (thermomètre, couverture, draps).
- **Soins** : bilan biologique à jeun (cholestérol, prothrombine, transaminases), repos absolu, régime riche en glucides/protides PAUVRE EN GRAISSES, suppression de l'alcool.
- **Traitement** : extraits hépatiques, vitamines, antibiotiques, corticoïdes — ÉVITER les médicaments hormonaux et progestatifs.
- **Surveillance** : tension 2×/j, courbe de poids, diurèse horaire, coloration selles/urines, signes de danger (persistance ictère, trouble conscience, COMA).

PROPHYLAXIE ET PRÉVENTION

- Désinfection literie, matériel à usage unique, hygiène rigoureuse des mains du personnel
- Éviter petites blessures (porte d'entrée du virus), gants pour soins et toilette
- **Vaccination (meilleure prévention)** : Hévac B — 3 injections à 1 mois d'intervalle + rappel à 1 an, puis tous les 5 ans.

À RETENIR

- L'hépatite B est une maladie à déclaration obligatoire.
- Le contrôle biologique doit être assuré tous les 3 mois la 1^{ère} année, puis tous les 6 mois la 2^e année.

12 RÔLE DE L'INFIRMIER AU COURS DE LA PONCTION D'ASCITE

DÉFINITION ET INDICATIONS

La ponction d'ascite consiste à introduire un trocart dans la cavité péritonéale pour prélever ou évacuer un épanchement liquidien. L'asepsie est fondamentale : l'ascite est un excellent milieu de culture chez le sujet immunodéprimé.

- **Indications** : cirrhoses, cancers digestif/ovarien/mammaire avec atteinte péritonéale.
- **Contre-indication** : trouble de la coagulation (TP > 50% requis).
- **Buts** : diagnostique (nature, étiologie, surinfection) et/ou thérapeutique (soulager une gêne cardio-respiratoire ou pariétale).

Aspect du liquide	Signification
Jaune clair	Ascite séro-fibrineuse
Rouge	Ascite hémorragique
Vert	Contient de la bile
Gélatineuse	Maladie gélatineuse du péritoine
Chyleuse	Graisse émulsionnée

COMPLICATIONS ET SURVEILLANCE

- **Complications** : infection péritonéale (asepsie+++), déshydratation/hypotension/choc, écoulement persistant après ablation.
- **Surveillance** : température, pouls-TA, diurèse, poids (perte NE doit PAS dépasser 1/2kg/jour) et périmètre abdominal.

À RETENIR

- L'analyse chimique distingue exsudats (protéines > 30g/l, processus inflammatoire/infectieux) et transsudats (protéines < 30g/l, épanchement mécanique).

13 RÔLE DE L'INFIRMIER AU COURS DU TUBAGE GASTRIQUE

DÉFINITION, BUTS ET INDICATIONS

Le tubage gastrique est réalisé par l'introduction, par les voies naturelles, d'un tube en caoutchouc dans l'estomac pour aspirer le contenu gastrique.

- **Buts** : prélever le contenu gastrique pour analyse, vider l'estomac, examen fonctionnel.
- **Indications** : prélèvement, fibroscopie, ulcère gastrique, gastrites.

- **Contre-indications** : tumeurs de l'œsophage, hémorragie digestive, ectasie.

PRÉPARATION DU MALADE

Expliquer l'innocuité réelle du tubage et l'effet désagréable au contact du pharynx (salivation abondante). Le malade doit faire de larges inspirations par le nez et des mouvements de déglutition pour favoriser la progression du tube.

À RETENIR

- Incidents possibles : la sonde peut s'enrouler dans la bouche ; salivation, nausées, efforts de toux sont fréquents et ne doivent pas alarmer.

14 RÔLE DE L'INFIRMIER AU COURS DE L'ASPIRATION DIGESTIVE

DÉFINITION, BUTS ET INDICATIONS

L'aspiration digestive évacue le contenu de l'estomac ou du duodénum à l'aide d'une sonde et d'un aspirateur.

- **Buts** : extraire les liquides, supprimer les obstacles d'occlusion, prévenir la distension intestinale.
- **Indications** : perforation, occlusion, chirurgies intestinales, avant/après intervention gastrique ou abdominale.
- **Contre-indications** : cancer de l'estomac/abdomen, hémorragies digestives.

SURVEILLANCE

- **Le malade** : constantes, changer la sonde nasale toutes les 48h, soins des narines réguliers — ÉVITER la compression de l'aile du nez (risque d'escarre narinaire).
- **Le dispositif** : fonctionnement de l'aspirateur, perméabilité et fixation de la sonde, renouveler la fixation au moment de la toilette.
- **Le liquide** : quantité/couleur/aspect, vider le bocal avant qu'il soit plein, noter les caractéristiques des sécrétions.

À RETENIR

- Toute observation doit être signalée au responsable et notée au dossier infirmier (transmission systématique).

15 RÔLE DE L'INFIRMIER DANS LA FONCTION BIOPSIQUE DU FOIE

DÉFINITION ET INDICATIONS

La ponction biopsique du foie consiste à prélever un fragment de parenchyme hépatique pour examen histologique.

- **Indications** : hépatites, cirrhose, cancer du foie.
- **Contre-indications** : syndrome hémorragique, obstructions biliaires, abcès du foie.

GESTES INFIRMIERS

- **Avant** : rassurer, informer sur le but, bilan hépatique+coagulation+groupe-rhésus, à jeun depuis 6h, matériel (aiguille spéciale de MENGHINI).
- **Pendant/après** : décubitus dorsal avec tronc/tête en légère rotation gauche, pansement après compression digitale 5-10min, repos au lit absolu avec surveillance des réactions.

À RETENIR

- Après la ponction, une compression digitale de 5 à 10 minutes est indispensable avant la pose du pansement pour prévenir l'hémorragie.

16 SOINS DE COLOSTOMIE OU ANUS ARTIFICIEL

DÉFINITION ET CONSÉQUENCES

La colostomie est un abouchement provisoire ou définitif d'un segment du côlon à la peau. Conséquences : perte du contrôle de l'exonération (continence), modification de l'image de soi.

RÔLE DE L'INFIRMIER

- **Rôle de surveillance** : observer l'aspect local de la stomie (rougeur, douleur, irritation), identifier diarrhée/constipation, adapter l'alimentation.
- **Rôle relationnel** : écoute face à la perturbation de l'image corporelle et aux troubles sexuels.
- **Rôle éducatif** : prévenir les complications locales, expliquer l'installation pour les soins, conseiller une vie normale en évitant sports violents et vêtements trop serrés.

À RETENIR

- Le soin de colostomie possède un objectif éducatif essentiel : permettre au patient de retrouver rapidement son autonomie.

17 SOINS INFIRMIERS EN CAS DE GASTRECTOMIE**DÉFINITION ET SOINS PRÉ-OPÉRATOIRES**

La gastrectomie est la résection partielle ou totale de l'estomac, nécessitant le rétablissement de la continuité digestive par anastomose gastro-duodénale ou gastro-jéjunale.

- **Si urgence (hémorragie)** : réanimation, examens sanguins urgents (crase, groupe-rhésus), champ opératoire.
- **Sans urgence** : surveillance des paramètres, préparation de l'estomac (alimentation liquide, lavage la veille), champ opératoire (rasage large), prémédication.

SOINS POST-OPÉRATOIRES ET RÉALIMENTATION

- **Jusqu'au réveil** : décubitus dorsal tête tournée, surveillance TOUTES LES 15 MIN (conscience, pouls, TA, pansement).
- **Réalimentation** : liquide 48 premières heures, puis progression par paliers jusqu'à une alimentation solide vers le 21^e jour, en mangeant lentement et en mâchant bien.

À RETENIR

- La réalimentation post-gastrectomie doit être extrêmement progressive : elle s'étale sur environ 3 semaines avant le retour à une alimentation solide.

CHAPITRE III — SOINS INFIRMIERS EN TRAUMATOLOGIE**18 SOINS INFIRMIERS AU PATIENT PRÉSENTANT UN TRAUMATISME DU RACHIS****À L'ARRIVÉE DU TRAUMATISÉ**

- MAINTENIR L'ALIGNEMENT DE L'AXE CRÂNIO-RACHIDIEN lors du transport
- Radios (face+profil, cliché bouche ouverte C1-C2), installer À PLAT sur plan dur
- Caler la tête si suspicion cervicale, pouls/TA, voie veineuse (Ringer lactate)
- **Surveiller/noter** : troubles de la sensibilité/motricité, de la vision, de la déglutition, respiratoires, des sphincters.

SUPPLÉER LA DÉPENDANCE DU BLESSÉ

- **Transit** : fibres, boissons abondantes, massages abdominaux, huile de paraffine.
- **Urines** : hydratation abondante, sonde vésicale, rééducation vésicale progressive.
- **Téguments** : hygiène, massages des points d'appui, matelas spécial, mobilisation EN UN SEUL BLOC.
- **Lever** : progressif si fracture stable, précoce si ostéosynthèse.

À RETENIR

- La dissociation pouls-température doit faire évoquer une complication thromboembolique.
- Le patient traumatisé du rachis nécessite une prise en charge cohérente par une équipe homogène, orientée vers l'autonomie et la réinsertion.

19 SOINS INFIRMIERS AU PATIENT PRÉSENTANT UN TRAUMATISME DU THORAX**INTRODUCTION ET RÔLE À L'ARRIVÉE**

La fracture de la paroi thoracique est grave par ses conséquences sur les viscères thoraciques (plèvre, poumon, bronches, organes médiastinaux). Les difficultés respiratoires précèdent les complications cardio-vasculaires : une réanimation en urgence peut être nécessaire.

- Installer en décubitus latéral du côté blessé si trouble de conscience, ou surélévation du tronc si conscient
- RECHERCHER UNE RESPIRATION PARADOXALE
- Thérapeutique urgente (aspiration trachéale, oxygénothérapie), voie veineuse contre le collapsus

SURVEILLANCE SELON LE STATUT VENTILATOIRE

Malade non intubé	Malade intubé
Position assise, bandage élastique du thorax, liberté des voies aériennes (aérosols), kinésithérapie respiratoire	Signes d'encombrement, aspirations trachéales, humidifier l'air, surveiller constantes ventilatoires (volume courant, pression)
À RETENIR • La gêne respiratoire entraîne une angoisse majeure chez le blessé et son entourage : l'infirmier doit être attentif et savoir rassurer.	

20 SOINS INFIRMIERS AU PATIENT PRÉSENTANT UN TRAUMATISME DU BASSIN

INTRODUCTION ET RÔLE À L'ARRIVÉE

Les fractures du bassin sont des traumatismes importants (souvent polytraumatismes), engageant le pronostic vital car les os de la ceinture pelvienne sont très vascularisés et saignent facilement. Les soins infirmiers doivent débiter IMMÉDIATEMENT.

- Installer prudemment en décubitus dorsal horizontal sur plan dur
- Rechercher une atteinte des organes mous (intestins, nerfs, système urinaire, vaisseaux)
- Bilan sanguin, cathéter veineux court de gros calibre

SURVEILLANCE PAR FONCTION

- **Urinaire** : aspect des urines, écoulement de sang par l'urètre — RUPTURE VESSIE = contractures, impossibilité d'uriner sans globe.
- **Digestive** : déceler perforations d'organes creux, contractures abdominales.
- **Cardio-vasculaire** : signes de choc hémorragique (pâleur, sueurs, pouls filant, TA effondrée), pouls fémoral.
- **Neurologique** : déficit sensitif/moteur localisé, troubles sphinctériens.

À RETENIR

- Le blessé du bassin présente de nombreux besoins : un plan de soins efficient est nécessaire pour bien mener sa prise en charge.

21 SOINS INFIRMIERS AU PATIENT PRÉSENTANT UN TRAUMATISME DU CRÂNE

ACCUEIL ET RÔLE INFIRMIER

La gravité du traumatisme crânien dépend de l'atteinte des structures sous-jacentes (méninges, hémisphères cérébraux, tronc cérébral). L'infirmier doit connaître les symptômes de gravité.

- Décubitus dorsal (tête sur champ/alèse) ; DÉCUBITUS LATÉRAL si inconscient (éviter l'inhalation)
- Interroger (heure accident, ébriété, perte de connaissance), inspecter les plaies
- Dépister à INTERVALLE RÉGULIER (1/2 ou 1/4h) tous les symptômes de gravité

SURVEILLANCE PAR FONCTION

- **Neurologique** : état de conscience, température, EEG et fond d'œil.
- **Respiratoire** : fréquence/amplitude, faire tousser si conscient, décubitus latéral.
- **Digestive** : à jeun quelques jours puis alimentation légère ; sonde gastrique si coma.
- **Urinaire** : hydratation et surveillance de la diurèse.

À RETENIR

- L'infirmier doit maintenir la relation avec le blessé même s'il est comateux, et l'aider vers la reprise de sa vie sociale et professionnelle.

22 SURVEILLANCE D'UN MALADE SOUS APPAREIL PLÂTRÉ

OBJECTIFS ET SIGNES DE BONNE CONFECTION

Le plâtre offre le danger de compression avec formation d'escarres : sa surveillance demande une attention particulière, surtout les premiers jours.

- **Objectifs** : réduire le déplacement, contenir la réduction, reprise fonctionnelle dès contention obtenue.
- **Signes de bonne confection** : extrémités ROSÉES, non gonflées, chaudes, sensibles mais non douloureuses, mobiles.
- **Causes de compression** : plâtre trop serré, œdème post-traumatique, hémorragie interne, rétraction par dessiccation.

COMPLICATIONS GRAVES

Complication	Signes / CAT
Syndrome des loges	Douleur MI, chaleur, crampes, absence pouls pédieux, dissociation pouls/température → CAT : mobilisation sous kinésithérapeute, contrôle pouls pédieux
Syndrome de Wolkman	Fourmillements doigts, œdème, cyanose, impotence → CAT : OUVERTURE IMMÉDIATE du plâtre
À RETENIR - Couleur des extrémités : BLEU = problème veineux/hématome, BLANC = problème artériel, ROUGE = problème infectieux. - Toute douleur sous plâtre impose son ouverture immédiate — c'est une règle absolue.	

23 PRISE EN CHARGE D'UNE PERSONNE EN TRACTION SUSPENSION ET EXTENSION CONTINUE

DÉFINITIONS ET BUTS

La traction suspension est une force appliquée sur une partie du corps en 2 directions opposées : elle favorise l'alignement osseux, lutte contre les contractures et diminue l'œdème. L'extension continue permet le maintien et la réduction des fractures.

- Types** : trans-osseuse (via clou/broche), suspension par attelle en U (hamac jambier), traction collée (sur la peau, utilisée chez l'enfant).
- Buts** : réduire progressivement une fracture ou une luxation de hanche, effet antalgique, immobiliser en attendant plâtre ou ostéosynthèse.

SURVEILLANCE ET PRÉVENTION DES COMPLICATIONS

- Infectieuses** : pansement de broche quotidien à la Bétadine, ne pas toucher la broche.
- Cutanées** : points d'appui, matelas anti-escarres, position du pied à 90° (prévenir l'équin).
- Thrombo-emboliques** : mobilisation régulière, contrôle du pouls pédieux et de la température.

À RETENIR

- Les poids de traction ne doivent JAMAIS être modifiés (diminués ou augmentés) sans prescription médicale.

24 SOINS PRÉ ET POST OPÉATOIRE DANS L'OSTÉOSYNTHÈSE

DÉFINITION ET SOINS PRÉ-OPÉATOIRES

L'infection est particulièrement redoutable en chirurgie orthopédique (défense des os/articulations médiocre). L'ostéosynthèse est un appareil permettant la contention des os fracturés, avec ou sans plâtre associé.

- Bilan biologique urgent (NFS, urée, glycémie, groupe-rhésus, crase sanguine)
- Traiter le choc et assurer la réanimation, radiographies
- Champ opératoire aseptique** : hors urgence, 2-3 jours de préparation (lavage savonneux, rasage étendu, champs alcoolisés renouvelés).

SOINS POST-OPÉATOIRES

- Position indiquée par le chirurgien, prévention systématique des escarres
- Surveiller le plâtre et le drainage, dépister hémorragie sous plâtre
- Contrôler régulièrement la température (dépister l'infection)
- Pansements avec asepsie rigoureuse (gants, champs, masque)

À RETENIR

- Détecter systématiquement les complications : escarres, infection, hémorragie, thrombophlébite, retard de consolidation.

CHAPITRE IV — SOINS INFIRMIERS DANS LES PATHOLOGIES RESPIRATOIRES

25 SOINS INFIRMIERS À UN MALADE PRÉSENTANT UNE DYSPNÉE

DÉFINITION ET ÉTIOLOGIES

Sensation consciente de difficulté respiratoire, résultant d'un déséquilibre entre la demande ventilatoire et les possibilités mécaniques thoraco-abdominales.

- **Étiologies principales** : insuffisance cardiaque (OAP), infection (bronchite, pneumopathie, pleurésie), fausse route, décompensation d'une pathologie chronique (BPCO), embolie pulmonaire, anémie, intoxication au CO.
- **NB** : prise en charge particulièrement rapide chez le sujet âgé, dont le terrain polypathologique peut entraîner un épuisement rapide.

SIGNES DE GRAVITÉ ET PREMIERS GESTES

Signes de gravité à rechercher

SpO₂ < 88% ; FR > 30 ou < 10/min ; pouls > 120 ; PAS < 80mmHg ; marbrures ; cyanose ; polypnée ; tirage ; troubles de conscience ; agitation ; flapping

- Libérer les VAS (ôter les prothèses dentaires), position demi-assise
- **Oxygène immédiat si gravité** : masque haute concentration ou lunettes < 6L/min. ATTENTION : si BPCO, ne jamais dépasser 2L/min.
- **Obstruction par corps étranger** : 5 claques vigoureuses entre les omoplates, puis manœuvre de HEIMLICH si insuffisant.

À RETENIR

- Chez le patient BPCO, une oxygénothérapie à trop fort débit peut aggraver la situation en supprimant le stimulus hypoxique de la respiration.

26 RÔLE DE L'INFIRMIER AU COURS DU DRAINAGE DE POSTURE (DDP)

DÉFINITION ET INDICATIONS

Soin facilitant l'écoulement des sécrétions pulmonaires/bronchiques par positionnement spécifique du malade selon la région à drainer.

- **Indications** : trouble de déglutition, paralysie des muscles respiratoires, encombrement bronchique diffus ou localisé, vomique.
- **Technique** : lobes supérieurs = position assise penchée en avant ou décubitus avec coussin ; lobe moyen/inférieur = position déclive latérale. Chaque séance comprend plusieurs positions et dure 30 à 60 minutes.

RÔLE DE L'INFIRMIER

- Faire comprendre la nécessité du soin, détendre le malade
- Noter aspect/quantité/odeur des expectorations
- Surveiller la cyanose lors des changements de position
- Prélever un échantillon pour analyse

À RETENIR

- Les séances doivent être répétées plusieurs fois par jour jusqu'au tarissement des écoulements, en débutant par des séances de 10 minutes.

27 SOINS INFIRMIERS DANS LES ASPIRATIONS DES SÉCRÉTIONS BRONCHIQUES

GÉNÉRALITÉS

Technique consistant à évacuer les sécrétions de l'arbre bronchique à l'aide d'une sonde reliée à un système d'aspiration — indiquée quand la toux ne suffit pas à débarrasser la trachée. Possible aussi chez le trachéotomisé.

- **Matériel** : sonde stérile, lubrifiant, eau stérile et antiseptique, système d'aspiration, gants stériles.
- **NB** : éviter les va-et-vient de la sonde (risque d'irriter la trachée). Noter la quantité de sécrétions après l'aspiration.

À RETENIR

- Après l'aspiration, réinstaller le malade, nettoyer et stériliser le matériel.

28 RÔLE DE L'INFIRMIER AU COURS DE L'INSTILLATION BRONCHIQUE

DÉFINITION ET PRÉPARATION

Mise en contact direct d'un antibiotique ou d'un médicament avec la muqueuse bronchique.

- **Indications** : suppuration bronchopulmonaire, dilatation des bronches, inflammation bronchique tenace.
- **Préparation 1ère séance** : à jeun strict dès la veille minuit, ne pas fumer, prémédication + atropine 3-4h avant.
- **Matériel** : anesthésie locale, sonde de METRAS (bout effilé + mandrin), aspirateur.

À RETENIR

- Surveillance : maintien de la position après l'instillation, faciès/respiration ; pas d'alimentation dans les heures qui suivent.

29 RÔLE DE L'INFIRMIER DANS LE LAVAGE DE LA PLÈVRE

DÉFINITION ET TECHNIQUE

Irrigation de la plèvre pour la débarrasser de ses impuretés — complète parfois la ponction évacuatrice ou le drainage aspiratif.

- **Indications** : pleurésie purulente après ponction évacuatrice, chirurgie thoracique.
- **Matériel** : sérum physiologique 500cc + antibiotique (ou enzymes fibrinolytiques), pleuro-laveur tournant.
- **Technique** : lavage jusqu'à obtention d'un liquide CLAIR ; ARRÊTER en cas de sensation de constriction thoracique.

À RETENIR

- Surveillance : respiration, toux, dyspnée, constantes (TA, pouls), faciès.

30 SOINS INFIRMIERS AU COURS DU DRAINAGE PLEURAL

DÉFINITION ET INDICATIONS

Introduction d'un drain dans l'espace pleural pour évacuer un épanchement gazeux (pneumothorax), hémorragique (hémothorax) ou liquidien (pleurésie).

- **Indications** : pneumothorax, hémothorax, pleurésie, pyothorax, chylothorax, drainage post-opératoire de chirurgie thoracique.
- **Risques à la pose** : malaise vagal, hémorragie (lésion artère intercostale), perforation d'organe, embolie gazeuse.

SURVEILLANCE DU DRAINAGE

- Position demi-assise (décubitus dorsal si intubé/inconscient)
- Quantité/aspect du liquide recueilli, bilan entrées-sorties
- **Débit** : SI > 200ml/h, AVERTIR LE MÉDECIN.
- Étanchéité des connexions, position déclive du système par rapport au patient
- Traire le drain toutes les 6 heures (progression des caillots/dépôts de fibrine)

À RETENIR

- Un débit de drainage supérieur à 200ml/h doit systématiquement être signalé au médecin sans délai.

31 SOINS INFIRMIERS DANS LA PONCTION DE LA PLÈVRE

DÉFINITION ET BUTS

Introduction d'une aiguille dans la cavité pleurale pour en prélever le contenu.

- **Buts** : diagnostique (nature du liquide), biopsique (plèvre/poumon), évacuatrice (dyspnée, cyanose, tachycardie), thérapeutique (lavage, injection).
- **Contre-indications** : trouble de l'hémostase, malformation des côtes.

RÔLE INFIRMIER ET INCIDENTS

- **Avant** : préparation psychologique (acte simple et courant), s'assurer de l'absence de traitement anticoagulant, vérifier les radios pulmonaires au dossier, prémédication 30min avant.
- **Incidents** : ponction blanche, malaise, hématome pariétal, OAP/toux, PNEUMOTHORAX, hémoptysie passagère.

À RETENIR

- La ponction pleurale est un acte médical : l'infirmier collabore avec le médecin et surveille le patient avant, pendant et après.

32 RÔLE DE L'INFIRMIER DEVANT UNE CRISE D'ASTHME ET L'ÉTAT DE MAL ASTHMATIQUE

LA CRISE D'ASTHME

Maladie chronique se traduisant par une bradypnée EXPIRATOIRE (lente, pénible, sifflante) par obstruction des voies aériennes.

- **Accueil en crise** : position assise (coussins), rassurer, sonnette à portée, voie veineuse, constantes, rechercher signes de gravité, appeler le médecin, oxygénothérapie.
- **Traitement** : CORTICOÏDES (Prednisone, Solumédrol® IV) et BÊTA-2-MIMÉTIQUES (Salbutamol/Ventoline®, Terbutaline/Bricanyl®).

ÉDUCATION À L'HYGIÈNE DE VIE

- Suivre scrupuleusement le traitement préventif (aérosols doseurs)
- **Supprimer les allergènes** : acariens, moquettes, phanères d'animaux, matelas en laine ; aérer la literie au soleil.
- NE PAS FUMER, retirer climatiseurs/humidificateurs
- Activité physique régulière non violente, climat sec et chaud
- **Médicaments contre-indiqués** : bêtabloquants, Prostigmine, vaccins à l'œuf si allergie.

À RETENIR

- Un état de mal asthmatique sous respirateur qui s'aggrave brusquement est FORTEMENT SUSPECT DE PNEUMOTHORAX : appeler immédiatement le médecin.

33 SOINS INFIRMIERS DEVANT UNE HÉMOPTYSIE

CONDUITE À TENIR

- Installer confortablement en position demi-assise, repos absolu au lit
- Approcher un récipient à chaque crachement de sang, chambre silencieuse et semi-éclairée
- Évaluer la quantité de sang rejetée, rassurer (patient souvent anxieux)
- Groupe sanguin + rhésus, numération globulaire + hématocrite, pouls/TA réguliers
- Transfusion sur avis médical ; radiologie d'urgence pratiquée au lit du malade

À RETENIR

- ISOLER le malade en cas de suspicion de tuberculose pulmonaire.

34 RÔLE DE L'INFIRMIER AU COURS DE L'INSUFFISANCE RESPIRATOIRE AIGÜE

RÔLE INFIRMIER

- Désencombrer/désobstruer les voies respiratoires
- **Positions** : 1/2 assise (faciliter expectoration) ou latérale de sécurité (si vomissements).
- Aspiration pharyngée, canule de Mayo, clapping
- **Si besoin** : intubation trachéale ou trachéotomie, oxygénation (sonde nasale ou ventilation artificielle).

POINTS DE VIGILANCE

- **Risque de COLLAPSUS ventilatoire** : chute de la TA si la ventilation est mise en route trop efficacement.
- **Chez l'IR chronique** : l'administration soudaine d'O₂ sans ventilation assistée peut provoquer une APNÉE par dépression bulbaire.
- **O₂ pur** : administré sans précaution, risque d'intoxication (convulsions, lésions pulmonaires).

À RETENIR

- Ne prendre aucune médication sans avis médical (AINS, AIS), prévenir le médecin de tout saignement, surveiller le Taux de Prothrombine.

CHAPITRE V — SOINS INFIRMIERS DANS LA FONCTION CARDIO-VASCULAIRE

35 RÔLE DE L'INFIRMIER DANS L'HYPERTENSION ARTÉRIELLE

CONFIRMER L'HTA

FORMATION PLUS

- Accueillir/rassurer, rechercher les signes par interrogatoire
- Repos 15 minutes avant la mesure
- **TA aux deux bras en position couchée** : répéter au moins 3 fois bien espacées avec LE MÊME APPAREIL.
- Référer en consultation médicale si chiffres élevés confirmés

MAINTENIR LA TA STABLE ET ÉDUCUER

- Réduction de la ration sodée (saler après cuisson), supprimer tabac/alcool
- **Si diurétiques** : ionogrammes réguliers, surveiller diurèse+poids tous les 3 jours.
- **Diététique** : augmenter fruits/légumes, limiter les corps gras (privilégier huiles végétales), diminuer les viandes (préférer volaille), poisson 2x/semaine, diminuer le sel, boire à volonté ($\geq 1,5\text{L/j}$).

À RETENIR

- La mesure de la TA doit toujours être répétée au moins 3 fois, à des consultations bien espacées, avec le même appareil, avant de retenir le diagnostic d'HTA.

36 PRISE EN CHARGE DES URGENCES HYPERTENSIVES

DÉFINITION ET SYMPTÔMES

PAS $> 220\text{mmHg}$ = danger sérieux. L'urgence hypertensive se définit non par un chiffre mais par une DYSFONCTION AIGUË évidente d'un organe vital (cardiovasculaire, neurologique, néphrologique).

- **Signes neurologiques** : paralysie (AVC), céphalées + syndrome méningé (hémorragie cérébrale).
- **Signes cardiovasculaires** : douleur thoracique, dyspnée aiguë (OAP).

CONDUITE À TENIR

- Position allongée + tronc surélevé (latérale de sécurité si trouble de conscience)
- Pouls/TA, calmer patient+entourage, appeler le médecin, oxygénothérapie
- Voie veineuse, bilan (ionogramme, urée, créatinine, glycémie, NFS), radio pulmonaire

À RETENIR

- Les véritables urgences hypertensives sont RARES : l'objectif est une réduction CONTRÔLÉE de la TA par voie parentérale, pour éviter de causer des dommages.

37 SOINS INFIRMIERS DANS L'ŒDÈME AIGU DU POUMON (OAP)

INSTALLATION ET SURVEILLANCE

- Ambiance calme, position demi-assise/assise jambes pendantes
- Oxygénothérapie 6-10L/min, voie veineuse gros calibre + sérum glucosé
- **Réduire la pression capillaire pulmonaire** : faire uriner, restriction hydrique, vasodilatation veineuse.
- Monitoring : TA, pouls, ECG, SaO₂

EXAMENS ET TRAITEMENT

- **Examens** : radio pulmonaire, urée/créatinine, ionogramme, enzymes cardiaques, gaz du sang.
- **Traitement** : DIURÉTIQUES — Lasilix® 1 ampoule ou Edécine®, si échec Lixi Léo®.
- **Éducation** : régime hyposodé + repos, surveillance des œdèmes par la prise de poids.

À RETENIR

- Signes de gravité à surveiller en continu : troubles de conscience, épuisement respiratoire, survenue d'un état de choc.

38 SOINS INFIRMIERS DANS L'EMBOLIE PULMONAIRE

CONDUITE À TENIR ET FACTEURS FAVORISANTS

- **Mobiliser AVEC PRÉCAUTION** : éviter la migration du caillot.
- Position demi-assise, tronc surélevé, oxygène selon tolérance, constantes
- **Bilan** : ECG, radio, angioscanner, D-dimères, enzymes cardiaques, gaz du sang, saturomètre.
- **Facteurs favorisants** : obésité, alitement, accouchement, chirurgie, pilule+tabac, varices/phlébite ancienne, arythmie/valvulopathie.

TRAITEMENT ET ÉDUCATION SOUS AVK

- **Traitement** : oxygénothérapie + héparinothérapie (JAMAIS d'IM, surveillance TCA).
- **Relais AVK** : environ 6 mois — respecter strictement la posologie, signaler gingivorragie/épistaxis, contrôle INR régulier, carte de traitement à présenter.

À RETENIR

- Le TCA sous héparine doit être équivalent à 2-3 fois le temps témoin. Prévenir le médecin de tout saignement prolongé.

39 RÔLE DE L'INFIRMIER DANS L'ANGINE DE POITRINE OU ANGOR

RÔLE INFIRMIER ET SURVEILLANCE

- À l'arrivée : repos, prévenir médecin, position demi-assise, rassurer
- **Surveillance** : douleur, TA/pouls toutes les 30min, ECG immédiat.
- Soins : nursing, prévenir la constipation, protéger du froid (déclenchant de crise)

ÉDUCATION DU MALADE

- Éviter les sorties par temps froid/venteux, éviter les efforts violents
- **ARRÊT DU TABAC** (bloque progressivement les artères)
- Réduire les graisses, activités douces (marche, vélo, natation — PAS d'aérobic/course)
- Réduire le stress et l'anxiété

À RETENIR

- Transcrire systématiquement au dossier de soins toutes les activités menées et informations données au patient.

40 RÔLE DE L'INFIRMIER DANS L'INFARCTUS DU MYOCARDE

ÉVALUATION ET PREMIERS GESTES

- Installer au lit (aucun effort), expliquer le déroulement de l'hospitalisation
- **Signes de gravité** : intensité de la douleur, pâleur, sueurs, vomissements, agitation, essoufflement.
- Constantes + prévenir le médecin, voie veineuse gros calibre
- **Si douleur persiste** : antalgique IV sur prescription. Traitement anticoagulant IVD lent.

SURVEILLANCE ET HYGIÈNE

- **Avertir le médecin si** : modification pouls/TA, reprise douleur, polypnée, modification ECG.
- **Hygiène** : toilette au lit sans participation 2-3 premiers jours, prévention escarres, rechercher phlébite débutante (palper mollets).
- **Éducation** : régime hypolipidique/sans sel, arrêt tabac.

À RETENIR

- La surveillance de la mise en route de l'oxygénothérapie vérifie : ralentissement du rythme respiratoire, disparition de la dyspnée, recoloration des téguments.

41 SOINS INFIRMIERS À UN MALADE ATTEINT D'INSUFFISANCE CARDIAQUE

DÉFINITION ET PRÉVENTION

Le cœur ne peut plus assurer le débit sanguin nécessaire aux tissus. Types : IC droite, IC gauche, IC globale.

- **Mesures préventives** : prévenir le RAA (traiter les angines), prévenir l'athérosclérose, éviter tabac/alcool/sports violents, traiter l'HTA, traiter toute angine de poitrine avant complication.
- **Hygiéno-diététique** : repos (diminue le travail cardiaque), régime pauvre en sel, alimentation équilibrée.

À RETENIR

- Mobiliser régulièrement les membres inférieurs au lit pour éviter la phlébite, position demi-assise recommandée.

42 RÔLE DE L'INFIRMIER DANS LA PHLÉBITE

PRÉVENTION ET DÉPISTAGE

- **Sujets à risque** : immobilisation post-opératoire, post-partum, IC droite, varices, cathéters de perfusion, œstroprogestatifs.
- **Interrogatoire** : douleur mollet/jambe, crampes avec impotence à la marche.
- **Palpation (COMPARER les 2 membres)** : douleur provoquée, CHALEUR locale, œdème NE PRENANT PAS LE GODET.

SURVEILLANCE PENDANT ET APRÈS

- **Pendant** : repos complet, pieds du lit surélevés, lever progressif et prudent quand autorisé, arceau pour le confort.
- **Après** : éduquer sur l'importance de la marche. Si hémorragie : ampoule de SULFATE DE PROTAMINE + prévenir le médecin.

À RETENIR

- Le pouls accéléré et une température inférieure à 38°C, associés à une douleur du mollet avec œdème ne prenant pas le godet, orientent vers une phlébite débutante.

43 SOINS INFIRMIERS EN PRÉ ET POST OPÉRATOIRE EN CHIRURGIE CARDIO-VASCULAIRE

INTRODUCTION ET SOINS PRÉ-OPÉRATOIRES

Hors urgences, l'entrée en chirurgie cardiologique est toujours PROGRAMMÉE.

- **Pathologies concernées** : valvulaires (remplacement/plastie), coronariennes (pontage PAC), vasculaires (pontage), sténoses carotidiennes (endartériectomie), greffes cardiaques.
- **Soins pré-opératoires** : accueil la veille, bilan d'entrée (radio pulmonaire, coronarographie, Doppler tronc supra-aortique, Doppler veineux).

À RETENIR

- Le rôle infirmier est l'application des prescriptions et l'entretien de la continuité globale de la prise en charge du patient.

44 CAT DEVANT UN MALADE PRÉSENTANT UN AVC

DÉFINITION, CAUSES ET SIGNES

Trouble de la vascularisation cérébrale d'installation subaiguë — traitement essentiellement symptomatique, dominé par les soins infirmiers.

- **Causes** : ischémie (artériosclérose, embolies) ou hémorragie (HTA, traumatismes crâniens).
- **Signes** : HÉMIPLÉGIE (installation brutale, signe de Babinski) ; syndrome méningé (raideur de nuque, Kernig, céphalées) ; déficits transitoires (aphasie, hémianopsie).

CONDUITE À TENIR

- **Médicaments** : anticoagulants si thrombose, vasodilatateurs cérébraux.
- **Perfusions** : surveiller étroitement le débit (éviter la surcharge), feuille de réanimation.
- **Prévention décubitus** : sondages vésicaux ASEPTIQUES, drainage de posture, soins de nursing, MATELAS ALTERNATING.

À RETENIR

- Tous les apports hydro-électrolytiques et alimentaires, ainsi que le volume et l'aspect des selles, urines et vomissements, doivent être consignés sur la feuille de réanimation.

45 LE PRÉLÈVEMENT SANGUIN

GÉNÉRALITÉS ET IMPORTANCE

Acte réalisable en milieu hospitalier ou ambulatoire, par personnel qualifié. HEURE IDÉALE : entre 7h et 9h du matin (avant 12h), certains paramètres étant influencés par une heure tardive (cortisol, fer, calcium).

- **Importance** : diagnostic (agents infectieux, modifications biologiques), surveillance thérapeutique, prévention. NB : le patient doit être à jeun.
- **Hygiène des mains** : 75-90% des infections nosocomiales sont manuportées. 4 types de lavage : simple, antiseptique, chirurgical, friction hydro-alcoolique.

PRÉCAUTIONS AES ET POINTS DE PONCTION

- **Risque après piqûre** : VHC/VHB 20-30%, VIH 0,4%. VACCINATION OBLIGATOIRE du personnel de santé.
- **Points de ponction** : pli du coude (veine céphalique = la moins douloureuse), dos de la main (plus douloureux), région malléolaire (rare).
- **Dispositifs** : seringue classique, tubes ouverts, ou PRÉLÈVEMENT SOUS VIDE (Vacutainer — le plus sécurisé).

À RETENIR

- Le port des gants est indispensable dès qu'un contact avec un agent infectieux est possible : un gant n'est pas une barrière totalement imperméable.

46 GROUPE SANGUIN

RAPPEL ET DÉTERMINATION

2 systèmes principaux : A.B.O (sujets A, B, AB, O — les O sont RECEVEURS UNIVERSELS) et RHÉSUS (positif/négatif). Toute transfusion doit être ISO-GROUPE ABO+Rhésus.

- **Groupe ABO** : méthode double — épreuve de BETH-VINCENT (sérum anti-A/anti-B sur les globules du patient) + épreuve de SIMONIN (sérum du patient sur globules connus).
- **Rhésus** : détermination de l'antigène D, toujours après le groupage ABO.

À RETENIR

- Les erreurs de groupage sont rarement biologiques : elles sont souvent liées à des ERREURS HUMAINES D'IDENTIFICATION ou de retranscription — le respect de la compatibilité ABO est une règle absolue de sécurité transfusionnelle.

47 TRANSFUSION SANGUINE

INDICATIONS, CONTRE-INDICATIONS ET MATÉRIEL

Administration IV de sang ou dérivé (plasma, culot globulaire, plaquettes) pour rétablir la masse sanguine ou un déficit d'un composant.

- **Indications** : hémorragie peropératoire, hémopathies, hémophilie, brûlures, choc hypovolémique.
- **Contre-indications** : insuffisance cardiaque, affections pulmonaires (embolie, OAP), HTA (risque de surcharge).
- **Matériel** : transfuseur+filtre, garrot, ampoule de calcium (prévenir les fourmillements).

ACCIDENTS TRANSFUSIONNELS ET SURVEILLANCE

- **Par incompatibilité** : hémolyse brutale — angoisse, dyspnée, douleurs dorsolombaires, choc → ARRÊTER LA TRANSFUSION dès les 1ers signes.
- **Infectieux** : hépatites (8% des receveurs), VIH — dépistage systématique depuis 1985.
- **Surveillance** : débit (éviter surcharge), pouls/TA, point d'injection (hématome).

À RETENIR

- Au moindre signe d'alarme, arrêter immédiatement la transfusion et vérifier les groupes donneur/receveur : toute erreur est évitable par la pratique rigoureuse.

48 RÔLE DE L'INFIRMIER DANS LES ANÉMIES

DÉFINITION ET DIAGNOSTIC

Hémoglobine inférieure à la norme (<13g/dl homme, <12g/dl femme) — carence martiale, en acide folique, ou en vitamine B12.

- **Diagnostic** : pâleur, asthénie, vertiges, troubles visuels, céphalées, tachycardie, hypotension, dyspnée.
- **Complications** : hypovolémie/choc si cause hémorragique, hypoxie, troubles neurologiques si carence B12.

RÔLE INFIRMIER

- Rechercher polyarthrite, AEG+fièvre, hématurie microscopique
- Interroger sur antécédents, constantes, dyspnée (dépister IC)
- Administrer traitement à l'heure prévue, éduquer sur le suivi et les risques

À RETENIR

- L'hémoglobine a besoin de fer, d'acide folique ou de vitamine B12 pour se renouveler : le type d'anémie oriente directement la supplémentation nécessaire.

49 SOINS INFIRMIERS DANS L'ÉTAT DE CHOC

DÉFINITION, CAUSES ET SYMPTÔMES

Défaillance de l'organisme ne parvenant plus à assurer une circulation sanguine correcte — déficit d'apport en oxygène, pronostic vital engagé.

- **Types** : SEPTIQUE (infection), HÉMORRAGIQUE, HYPOVOLÉMIQUE (déshydratation), CARDIOGÉNIQUE, ANAPHYLACTIQUE (allergie fulgurante).
- **Symptômes** : polypnée, hypoxémie ($SpO_2 < 90\%$), hypotension, tachy/bradycardie, cyanose/marbrures, malaise, hypothermie.

TRAITEMENT ET CAT INFIRMIER

- **Traitement** : réduire l'hypovolémie, accès veineux (remplissage/transfusion), oxygénothérapie, chirurgie si hémorragie interne.
- **CAT** : conscient (allonger, lever les jambes) ; inconscient (PLS) ; arrêt cardiaque (massage) ; hémorragique (point compressif).

À RETENIR

- Le premier traitement est le plus souvent le remplissage par macromolécules ; la surveillance ultérieure (constantes, diurèse, conscience) reste indispensable.

50 CAT DEVANT UNE SYNCOPÉ

DÉFINITION, CAUSES ET SIGNES

Perte momentanée de connaissance, de sensibilité et du mouvement volontaire, avec arrêt de la respiration et de la circulation.

- **Causes** : névropathies, fatigue/peur/émotions, cardio-vasculaire, cérébrale, infectieuse.
- **Signes** : bourdonnement d'oreilles, éblouissement, vertiges, perte de connaissance de durée variable, pâleur, pouls filant.

À RETENIR

- Traitement : étendre tête basse, toni-cardiaques (Hept-amyl), respiration artificielle si besoin, oxygénothérapie (cas grave), massage cardiaque.

CHAPITRE VI — SOINS INFIRMIERS DANS LA FONCTION RENALE

51 SONDAGE VÉSICAL

DÉFINITION, INDICATIONS ET MATÉRIEL

Introduction aseptique d'une sonde dans la vessie par l'urètre pour permettre l'écoulement des urines. But : évacuateur, diagnostique, thérapeutique.

- **Indications** : rétention d'urine (adénome prostatique), incontinence chez la personne âgée à risque cutané, surveillance en soins intensifs.
- **Contre-indications** : suspicion de rupture de l'urètre, traumatisme du bassin, infection urogénitale.
- **Précaution** : cathétérisme TRÈS ASEPTIQUE — ne pas inoculer une vessie en rétention (prédispose à l'infection).

SURVEILLANCE ET RÔLE INFIRMIER

- **Surveillance** : diurèse $> 50\text{ml/h}$, couleur/odeur urines, système clos, hygiène biquotidienne.
- **SI GLOBE VÉSICAL** : vidanger progressivement par $300\text{ml}/1/4\text{h}$ (éviter l'œdème et l'hémorragie a vacuo).
- **Sonde à demeure** : toilette minutieuse, ne PAS exercer de traction, sonde passée AU-DESSUS de la cuisse, clamper la tubulure lors du changement de sac.

À RETENIR

- La sonde à demeure constitue un véritable drain physiologique : laissée ouverte, elle met la vessie au repos complet.

52 LAVAGE DE VESSIE

DÉFINITION, BUTS ET INCIDENTS

Introduction d'une certaine quantité de liquide dans la vessie (via une sonde) puis élimination immédiate.

- **Buts** : désinfection, hémostatique, décongestif.
- **Indications** : avant/après intervention vessie, avant cystoscopie, prévention cystite, hématurie de faible abondance.
- **Matériel** : nécessaire sondage vésical, seringue vésicale (Bonneau/Guyon).

À RETENIR

- Incidents : liquide qui revient par le méat (sonde pas assez profonde), douleur si dilatation trop brusque de la vessie.

53 RÔLE DE L'INFIRMIER DEVANT UNE HÉMATURIE

RÔLE INFIRMIER ET URGENCE HÉMODYNAMIQUE

- Installer/rassurer, interroger sur les circonstances
- Analyse d'urines, bilan (hématocrite, NFS)
- **Urgence hémodynamique** : cathéter veineux (sérum glucosé, plasma) puis transfusion si besoin — MALGRÉ L'URGENCE, vérification indispensable du test de compatibilité.
- **Examens** : cystoscopie, cathétérisme urétral, urographie IV.

CIRCONSTANCES ÉVOCATRICES

Circonstance	Orientation
Précédée de douleurs lombaires	Lithiase
Accompagnée de douleurs vésicales	Cystite
Spontanée, non douloureuse	Cancer du rein (à évoquer)

À RETENIR

- Un traitement anticoagulant peut provoquer une hématurie SANS lésion vésicale sous-jacente.

54 RÔLE DE L'INFIRMIER DEVANT UNE INSUFFISANCE RÉNALE AIGÜE

SURVEILLANCE ET APPORTS

- **Urgence** : reconnaître la VÉRITABLE ANURIE (ne pas la confondre avec un globe vésical), sonder, peser, constantes, avvertir le médecin.
- **Apports liquidiens** : MÉNAGER LE REIN — limiter à 500cc/jour MAXIMUM, régime HYPOPOTIDIQUE ET HYPOSODÉ.
- **Si urée > 3,5g** : recourir aux méthodes extra-rénales (dialyse/hémodialyse).

À RETENIR

- Prudence avec les aminosides (streptomycine, gentamycine) et les tonicardiaques, néphrotoxiques. Les infections urinaires sont souvent responsables d'insuffisances rénales graves.

55 RÔLE DE L'INFIRMIER DEVANT L'INSUFFISANCE RÉNALE CHRONIQUE

AVANT LES SÉANCES D'HÉMODIALYSE

- **Préserver le capital veineux** : future voie d'abord vasculaire — piquer plutôt au dos de la main, garder UN bras indemne de toute ponction.

SURVEILLANCE

- Taille (annuelle), poids (journalier)
- **TA** : patient au repos 15min assis/couché puis debout après 1min (recherche hypotension orthostatique).
- Diurèse (collecte urines+protéinurie/24h à l'entrée)
- **Traitement** : diurétiques le matin (éviter les pollakiuries nocturnes), régime à restriction sodée.

À RETENIR

- Le capital veineux d'un insuffisant rénal chronique doit être préservé dès le diagnostic, en vue d'une future fistule artério-veineuse.

56 RÔLE DE L'INFIRMIER DEVANT LA COLIQUE NÉPHRÉTIQUE

SURVEILLANCE ET CONDUITE À TENIR

- **Surveillance clinique** : douleur, pâleur/sueurs, nausées/vomissements, hématurie, diurèse.
- **Bilan** : urée, créatinine, PH urinaire, ECBU, ionogramme. Radio : ASP (calculs radio-opaques), urographie IV.
- **CAT** : ARRÊTER TOUT APPORT LIQUIDIEN IMMÉDIATEMENT (réduit la tension des voies excrétrices), TAMISER LES URINES (récupérer un éventuel calcul), antalgiques sur avis médical.

ÉDUCATION

- Boissons abondantes, alcalinisation (sérum bicarbonaté, Vichy)
- Antispasmodiques/AINS, réduire aliments riches en calcium/protides
- Consultation urologique

À RETENIR

- La restriction hydrique doit être maintenue jusqu'à la sédation complète de la douleur, qui peut durer plus de 6 heures.

57 RÔLE DE L'INFIRMIER DEVANT LE SYNDROME NÉPHROTIQUE

SURVEILLANCE DU TRAITEMENT

- **Collecte des urines/24h**. Surveillance traitement diurétique : poids quotidien, TA, faiblesse musculaire/crampes.
- **Surveiller la kaliémie** : signaler toute valeur < 4 et $> 3,5$ mEq/l.
- **Surveillance corticothérapie** : pesée quotidienne, TA, régime SANS SEL strict, troubles électrolytiques, glycémie.

COMPLICATIONS À SURVEILLER

- Ostéo-articulaires : ostéoporose, nécrose aseptique de la tête fémorale
- Digestives : brûlure digestive
- Infectieuses : fièvre, toux, dyspnée
- Psychiques : insomnie, excitation anormale

À RETENIR

- Le régime sans sel strict est un pilier de la surveillance du traitement corticoïde dans le syndrome néphrotique.

58 RÔLE DE L'INFIRMIER DEVANT LA PYÉLONÉPHRITE AIGÜE

TRAITEMENT ET SUIVI

- **Traitement** : antibiotiques à FORTE DOSE par voie injectable pendant 24h, puis relais par voie orale si la fièvre tombe.
- **Poursuite** : demander à la patiente de poursuivre le traitement oral plusieurs semaines après la sortie, même si les symptômes urinaires ont totalement disparu.
- **Suivi** : RDV de contrôle, précautions après les rapports sexuels (uriner immédiatement après, antibiotique per os).

À RETENIR

- L'arrêt prématuré du traitement, même après disparition des symptômes, est le principal risque de récurrence/complication de la pyélonéphrite.

59 CONDUITE À TENIR DANS LA RÉTENTION AIGÜE D'URINE

DÉFINITION ET CAT

Impossibilité d'uriner malgré l'envie et le déclenchement de la miction, vessie pleine — obstacle brutal à l'évacuation (GLOBE VÉSICAL).

- **Urgence** : sondage vésical (sonde stérile par l'urètre) ; cathéter SUS-PUBIEN si sondage impossible (volumineuse prostate, sténose urètre).
- **Évacuation LENTE** : clamber 200ml toutes les 10min — éviter l'hémorragie a vacuo.
- **Prélèvements** : ionogramme, urée, créatinine, NFS, ECBU si fièvre.

À RETENIR

- Quantifier systématiquement les urines recueillies et appeler le médecin pour confirmation du diagnostic et organisation du drainage.

60 SOINS INFIRMIERS DANS L'ADÉNOMECTOMIE DE LA PROSTATE**INTRODUCTION ET SOINS POST-OPÉRATOIRES**

Chirurgie de l'homme âgé souvent fatigué/porteur de tares — suites parfois préoccupantes (hémorragie, infection, thrombose veineuse).

- **Soins post-opératoires** : DRAINAGE VÉSICAL très important, lever précoce le lendemain, reprise du transit dès la 48e heure.
- **Sonde urinaire** : PERMÉABILITÉ à assurer (désobstruction aseptique), en place 8-12 jours minimum ou jusqu'à urines claires, LAVAGE CONTINU DE LA VESSIE.

COMPLICATIONS POST-OPÉRATOIRES

- **Hémorragie** : la complication la plus fréquente — surveillance attentive contre la formation de caillots vésicaux.
- Infection (septicémie ou locorégionale), oligo-anurie, phlébite (risque embolie)

À RETENIR

- Le respect scrupuleux des étapes de soins avant et après l'intervention garantit des suites favorables.

CHAPITRE VII — SOINS INFIRMIERS EN RHUMATOLOGIE**61 SOINS INFIRMIERS DANS LE RHUMATISME ARTICULAIRE AIGU (RAA)****DÉFINITION ET RÔLE AVANT DIAGNOSTIC**

RAA (maladie de Bouillaud) — affection de l'enfant/adulte jeune (5-15 ans) : manifestations articulaires bruyantes/fugaces/sans gravité MAIS atteinte cardiaque sournoise/persistante/grave. Apparaît brutalement 15 jours après une angine.

- **Rôle infirmier** : courbe de température/TA/diurèse/pouls, ALBUMINURIE (symptôme de néphrite rhumatismale).
- **Évolution favorable attendue** : amélioration rapide, TA qui ne s'élève pas, diurèse stable, poids stable, douleurs qui décroissent.
- **Accidents thérapeutiques à détecter** : œdèmes, épigastralgie, hémorragie digestive, vertiges, COMA ACIDOSIQUE (salicylés).

DÉPISTAGE ET ÉDUCATION

- Toute angine, même minime, doit être prise en charge
- Orienter tout enfant (5-15 ans) présentant une angine vers une consultation médicale
- Repos complet jusqu'à disparition des flexions articulaires, protéger les articulations (cerceau)

À RETENIR

- Le traitement systématique de l'angine à la pénicilline reste la meilleure prévention primaire du RAA et de ses atteintes cardiaques graves.

62 SOINS INFIRMIERS À UN PATIENT ATTEINT DE LA SCIATIQUE**DÉFINITION ET SYMPTÔMES**

Affection douloureuse radiculaire unilatérale par irritation/compression du nerf sciatique — cause la plus fréquente : HERNIE DISCALE.

- **Symptômes** : douleur lombaire irradiant fesse/cuisse/jambe, aggravée le soir, calmée par le repos, MAJORÉE PAR LA TOUX/ÉTERNUEMENT.
- **Traitement** : repos strict, antalgiques, anti-inflammatoires, décontractants, parfois chirurgie.

CAT INFIRMIÈRE ET ÉDUCATION

- **Installation** : décubitus dorsal, plan dur, genoux demi-fléchis sur coussin, arceau de lit.
- **Surveiller** : SIGNES DE GRAVITÉ (paralysie, dysurie, incontinence — syndrome de la queue de cheval).

- **Éducation** : éviter station debout prolongée/charges lourdes/talons hauts, matelas ferme, bonnes pratiques de manutention (fléchir les jambes, dos droit), natation/marche.

À RETENIR

- Toute apparition de troubles sphinctériens (dysurie, incontinence) associée à la sciatique est un signe de gravité imposant une prise en charge urgente.

CHAPITRE VIII — SOINS INFIRMIERS DANS L'ADMINISTRATION DES MÉDICAMENTS**63 RANGEMENT D'UNE ARMOIRE À PHARMACIE****RANGEMENT DE L'ARMOIRE**

- **État de l'armoire** : bon état, clés, propreté.
- **Bons de commande** : entrée/sortie des médicaments, fiches de stock (inventaire).
- **Classement** : par tableau (A,B,C), par forme médicamenteuse, par appareil (respiratoire, digestif, urinaire), usage interne/externe séparés.
- **NB** : l'armoire doit être sous la responsabilité d'un agent INTÈGRE.

PRÉCAUTIONS LORS DE L'ADMINISTRATION

- **Identification du bénéficiaire**, prescription sans ambiguïté (se méfier des noms/chiffres ressemblants).
- **Règle de lecture** : lire le nom du médicament au transport ET au rangement.
- **Voie d'administration** : IM, IV, SC, IR, ID — sinon RISQUE VITAL pour le bénéficiaire.
- **Jugement clinique** : demander un complément d'information à l'équipe (médecins, pharmaciens) en cas de doute.

À RETENIR

- La bonne administration des médicaments est un facteur déterminant de la guérison du bénéficiaire : elle exige précision et vigilance accrue.

64 SURVEILLANCE D'UN PATIENT SOUS DIURÉTIQUES**DÉFINITION ET INDICATIONS**

Augmentent l'excrétion rénale de sodium (inhibent la réabsorption tubulaire).

Groupe	Exemple
Diurétiques osmotiques	Mannitol
Diurétiques de l'anse	Lasilix
Épargneurs de potassium	Antialdostérones

- **Indications** : HTA, œdèmes, insuffisance cardiaque/hépatique, syndrome néphrotique, glaucome, OAP.
- **Surveillance** : POIDS (indispensable), diurèse, ionogramme, ECG, crise de goutte.

À RETENIR

- **RÈGLE D'OR** : « JAMAIS de chlorure de potassium en IVD ». Signes d'efficacité : augmentation de la diurèse, baisse du poids, fonte des œdèmes.

65 SURVEILLANCE D'UN MALADE SOUS ANTICOAGULANTS**DÉFINITION, INDICATIONS ET CONTRE-INDICATIONS**

Médicaments s'opposant à la formation de thromboses (allongent le temps de coagulation). 3 groupes : HÉPARINE et dérivés, ANTIVITAMINES K, fibrinolytiques.

- **Contre-indications** : antécédent de thrombopénie, AVC hémorragique, >75ans, cirrhose, grossesse. NE PAS ASSOCIER : aspirine, corticoïdes, sulfamides, quinine.
- **Surveillance clinique** : signes de SURDOSAGE (ecchymoses, épistaxis, gingivorragie, méléna, hématurie) ou de SOUS-DOSAGE (récidive de thrombose).

CONDUITE À TENIR EN CAS D'ACCIDENT HÉMORRAGIQUE

- Grouper le malade, avertir le médecin, DIMINUER LA DOSE

FORMATION PLUS

- **Traitement spécifique** : vitamine K1 si AVK ; SULFATE DE PROTAMINE si héparine (1mg/100UI).
- NE JAMAIS ARRÊTER BRUTALEMENT le traitement en cas d'incident mineur

À RETENIR

- L'éducation du patient est essentielle : pas d'automédication, dépister toute hémorragie, éducation alimentaire.

66 SURVEILLANCE D'UN PATIENT SOUS INSULINE

TYPES ET SURVEILLANCE

- **Types** : action rapide (5-8h), intermédiaire mono/biphasique (12-20h), longue durée (20-30h).
- **Glycémie capillaire PLURIQUOTIDIENNE** : équilibre si <1,3g à jeun et <1,8g postprandial.
- **Si glycémie >2g/l** : rechercher une cétonurie.
- Poids/taille/TA à chaque visite, points d'injection (lipodystrophie)

À RETENIR

- PENSER À L'ACIDOCÉTOSE en cas de déshydratation extracellulaire + dyspnée caractéristique + douleurs abdominales/vomissements : ce tableau peut simuler une urgence chirurgicale.

67 RÔLE DE L'INFIRMIER DANS LA CORTICOTHÉRAPIE PAR VOIE GÉNÉRALE

INDICATIONS ET CONTRE-INDICATIONS

Puissantes propriétés anti-inflammatoires, anti-allergiques, immuno-modulatrices. Principaux : prednisone, prednisolone, méthylprednisolone.

- **Indications longue durée** : polyarthrite rhumatoïde, maladie de Horton, lupus, asthme.
- **Cure courte** : urgences (choc anaphylactique, état de mal asthmatique, œdème laryngé, épiglottite aiguë).
- **Contre-indication principale** : PROCESSUS INFECTIEUX SÉVÈRE ÉVOLUTIF non contrôlé.

COMPLICATIONS ET MODALITÉS D'ARRÊT

- **Règle d'or** : dose la plus faible possible, durée la plus courte possible (surtout si >7mg/j prolongé).
- **Complications** : syndrome de sevrage, diabète cortico-induit, HTA, OSTÉOPOROSE, ostéonécroses, myopathie, cataracte.
- **Prescription** : PRISE LE MATIN (réduit l'impact sur l'axe cortico-surrénalien).

À RETENIR

- L'arrêt d'une corticothérapie prolongée doit TOUJOURS être PROGRESSIF, par paliers, pour éviter l'effet rebond et l'insuffisance surrénalienne aiguë.

68 SURVEILLANCE D'UN MALADE SOUS CORTICOÏDES ET AINS

PRINCIPAUX RISQUES À PRÉVENIR ET DÉPISTER

Risque	Surveillance / Prévention
Hyperglycémie	Glycémie sur PM, régime diabétique (proscrire sucres rapides)
Fonte musculaire / cicatrisation	Régime hyperprotidique, surveiller la peau, prévention escarres
Dyslipidémie / faciès cushingoïde	Bilan lipidique, régime hypolipidémiant, surveiller le vécu psychologique
Œdèmes / HTA / OAP	Régime DÉSODÉ, surveiller poids et signes d'OAP
Hypokaliémie (crampes)	Kaliémie, ECG sur PM, supplémentation potassique
Risque infectieux	Antibioprophylaxie sur PM, hygiène des mains, vaccins à jour
Gastralgie / ulcère	Pansement gastrique sur PM (2h avant la prise) ou anti-ulcéreux

À RETENIR

- Ces effets indésirables relèvent à la fois du rôle en collaboration (prescriptions sur PM) et du rôle propre de l'infirmier (surveillance, diagnostic infirmier d'image corporelle perturbée).

69 SURVEILLANCE D'UN PATIENT SOUS ANTIBIOTIQUES

VÉRIFICATIONS ET SURVEILLANCE

- **Vérifications** : ALLERGIE CONNUE (dossier médical), prélèvements bactériologiques faits AVANT le traitement (hémoculture, ECBU).
- **Surveillance** : T°, pouls, TA, FR, diurèse, poids.
- **Effets secondaires principaux** : troubles digestifs (25%), CANDIDOSE, CHOC ANAPHYLACTIQUE (chute TA, œdème de la glotte, urticaire géant).

EFFETS SPÉCIFIQUES PAR CLASSE ET RÈGLE GÉNÉRALE

Classe	Effet spécifique
Pénicillines / Céphalosporines	Néphrotoxicité, allergie croisée entre les deux classes
Aminosides	Ototoxicité irréversible (durée < 7 jours par précaution)
Quinolones	Tendinite, rupture du tendon d'Achille
Tétracyclines	Coloration jaune des dents (CI enfant < 8 ans, femme enceinte)
À RETENIR • Règle des « 3 frappes » : frapper vite (dès J1), frapper fort (dose thérapeutique d'emblée), frapper continuellement (durée minimum 7 jours, jamais d'arrêt brutal).	

70 INCIDENTS ET ACCIDENTS DUS AUX SULFAMIDES ET ANTIBIOTIQUES

DÉFINITIONS ET ACCIDENTS DES SULFAMIDES

Antibiotiques = substances s'opposant au développement des germes pathogènes sans toxicité aux doses thérapeutiques.
Sulfamides = produits chimiques à groupement sulfamide, à pouvoir bactéricide.

- **Risques cutanéomuqueux** : urticaire, œdème, SYNDROME DE LYELL (nécrose épidermique bulleuse extensive) — le plus grave, surtout avec les sulfamides retard.
- **Accidents rénaux** : néphrite, colique néphrétique, hématurie, anurie — prévenus par une hydratation abondante et l'alcalinisation des urines.
- **Accidents hématologiques** : aplasie — contrôle NFS systématique pour déceler une leucopénie d'alarme.

ACCIDENTS DUS AUX ANTIBIOTIQUES

- **Bêta-lactamines** : allergies, hémorragies, résistances (surtout pénicillines), granulopénies/thrombopénies rares.

À RETENIR

- Les accidents graves aux sulfamides sont largement prévenus par une hydratation abondante du patient et l'alcalinisation des urines au bicarbonate de sodium.